PENSE-BÊTE · MÉTHODES ET GOUVERNANCE

Gestion du risque suicidaire en milieu hospitalier

14-96 Risque suicidaire au travail - repérage, conduite à tenir et postvention (1 sur 2) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'employeur doit assurer l'hygiène et la sécurité en privilégiant la protection collective et l'adaptation du travail à l'homme.
2. L'imputabilité au service est présumée pour un fonctionnaire si le geste survient au temps et au lieu du travail.
3. Le numéro 3114 permet une prise en charge gratuite des personnes ayant des idées suicidaires 24H/24 7J/7.

Présentation et méthodologie du guide

Notion	À retenir
Contexte et objectifs	Recherche commandée par la **Fédération Hospitalière de France**. Compréhension, prévention et réaction face au risque suicidaire via **revue de littérature** et **étude qualitative** (entretiens d'experts).
Équipe de recherche	Équipe **interdisciplinaire** (**Universités de Nîmes et d'Aix-Marseille**) : Maître de Conférences (management, psychologie clinique, design), Professeur (psychologie sociale).
Structure documentation	Livrable : **3 livrets** (phénomène, détection/prévention, gestion de crise) et **2 posters** (formats **A4** et **A3**) synthétisant les livrets **1** et **2**.

Cadre juridique de la prévention

Notion	À retenir
Obligations employeur	Assurer l'hygiène et la sécurité pour préserver la santé et l'intégrité physique (**art. 23 loi n° 83-634**). Code du travail applicable (**art. L. 4111-1** : établissements de santé, sociaux et médico-sociaux ; agents de l'art. 2 de la loi n° 86-33).
Principes prévention	Protéger santé **physique et mentale**. Priorité à la **protection collective** sur l'individuelle. Combattre les risques à la source et adapter le travail à l'homme.
Document unique	Le **DUERP** (**art. R4121-1, R4121-2**) recense les risques (médicaux et non médicaux). Évaluation **au moins une fois par an** ou lors d'un aménagement important.

Identification des signes et contextes à risque

Notion	À retenir
Signes comportementaux	Repli sur soi, incapacité relationnelle, sentiment de solitude, échec, perte d'espoir, dévalorisation, irritabilité, agitation, insatisfaction, agressivité, impulsivité, sommeil détérioré ou mise en ordre des affaires.
Facteurs de vulnérabilité	Perte récente ou changement important des conditions de travail, **dépression**, **burn-out**, fatigue inexpliquée, événement humiliant, hausse consommation **alcool/drogues/tabac**, modification état de santé.
Analyse des signaux	Guetter les **signaux faibles** (préparation sur **ordinateur**, fatigue, pression intense) ; actes souvent **imprévisibles** ; qui menace est parfois loin de l'acte, qui veut mourir ne l'annonce pas forcément.

Accompagnement et procédures

Notion	À retenir
Prise en charge	Prévenir le **stress post traumatique** via moyens **médico-psychologiques internes**. Soutien de la **famille** (droits, circonstances) et proposition du **service social**. Présence aux obsèques souhaitable.
Procédures d'information	Formation spécialisée (**CSA/CSE**) réunie au plus vite, enquête si accident grave. Information **obligatoire** à l'**inspection du travail** si décès. Délai : immédiatement ou sous **12 heures** (art. **R. 4121-5** code travail).
Rôle de la CUMP	Mise en place par l'**ARS** (établissement siège du SAMU, art. **R. 6311-25 CSP**). Prise en charge par **psychiatres, psychologues, infirmiers**. Coordonnée par un **psychiatre référent**. Relais possible par le **service prévention et santé au travail**.

Régime de l'imputabilité au service

Notion	À retenir
Fonctionnaires	Imputabilité présumée (**art. L. 822-18 CGFP**) au temps/lieu du service ou prolongement normal, sauf **faute personnelle** ou **circonstance particulière**. Décision en **1 mois** (+ **3 mois** si médecin agréé/conseil médical). Recours : juge administratif.
Agents non fonctionnaires	Régis par **art. L. 411-1 CSS**. Compétence : **CPAM**. Présomption au temps/lieu de travail (charge de la preuve à la **CPAM**). Hors lien de subordination : l'agent doit établir le fait du travail.
Jurisprudence lien direct	Présomption au temps/lieu du service (**CE 16/07/2014**). Imputabilité hors temps/lieu si lien direct établi (**CAA Douai 27/06/2023**). Rejet si absence de soudaineté (**CAA Paris 20/11/2023**) ou pathologie préexistante (**CAA Marseille 19/10/2021**).

Conséquences de la reconnaissance comme accident du travail

Notion	À retenir
Prestations et congés	Fonctionnaire : **CITIS** (art. L. 822-21 CGFP), traitement intégral (L. 822-22). Contractuels : plein traitement **1 mois** (après 1 mois), **2** (après 1 an), **3** (après 3 ans). Praticiens hospitaliers : max **5 ans** (R. 6152-23 CSP).
Réparations et pensions	Fonctionnaire : **ATI** (art. L. 824-1 CGFP) si incapacité ≥ **10 %** ; État : **rente viagère** (radiation anticipée) ; réversion **50 %** ; orphelin < 21 ans **10 %** (+ 10 % rente). Non-fonctionnaire : < 10 % capital, ≥ 10 % rente.
Indemnisations et aides	Fonctionnaire : **remboursement des frais** (art. L. 822-24 CGFP), **capital décès** = **12 fois** le dernier traitement indiciaire brut mensuel (art. D. 712-23-1 CSS). Non-fonctionnaire : capital décès forfaitaire (L. 361-1 CSS).

Ressources et dispositifs d'aide

Notion	À retenir
Recommandations HAS	**Médecin du travail** et **infirmier** : interlocuteurs privilégiés. Interroger sur les idées suicidaires (notamment après **arrêt maladie**). Rechercher l'abus de **toxiques**. **Médecin généraliste** : premier interlocuteur du soin. **Urgence** : si troubles psychiques aigus.
Numéros et dispositifs	**3114** (santé mentale) : lancé le **1er octobre 2021**, gratuit, **24H/24 7J/7**. **PSSM France** (créée en **2018**) : formation de secouristes en santé mentale.
Outils de prévention	**Plaquette d'information** pour les agents. **Kit d'outils d'accompagnement** (PDF) pour RPS. **Référentiels de formation**, **indicateurs de diagnostic** et guide **PSSM** pour employeurs.

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre la présomption d'imputabilité (temps et lieu du travail) avec un acte survenant hors de ces cadres.
- ⚠ Appliquer le même code à tous : fonctionnaires (CGFP) et non fonctionnaires (code de la sécurité sociale).
- ⚠ Penser que les signes annonciateurs sont des règles garantissant le passage à l'acte.
- ⚠ Confondre la compétence de l'établissement public de santé pour les fonctionnaires avec celle de la CPAM pour les agents non fonctionnaires.
- ⚠ Croire que la personne qui veut réellement mourir l'annonce forcément.

Sigles et définitions

DUERP	document unique pour la prévention des risques professionnels recensant les risques des personnels.
CUMP	cellule d'urgence médico-psychologique mise en place par l'ARS.
CITIS	congé pour invalidité temporaire imputable au service pour le fonctionnaire.
imputabilité au service	reconnaissance qu'un suicide ou une tentative de suicide est lié directement au travail.
CPAM	caisse primaire d'assurance maladie compétente pour les agents publics non fonctionnaires.
PSSM	association française des premiers secours en santé mentale.
3114	numéro national de prévention du suicide lancé le 1er octobre 2021.
accident du travail	événement reconnu imputable au service ouvrant droit à des prestations et indemnisations.

Auto-test

1. Quelle est la priorité de l'employeur en matière de prévention ?
2. À quelle fréquence le DUERP doit-il être évalué au minimum ?
3. Qui décide de l'imputabilité pour un agent non fonctionnaire ?
4. Quel est le montant du capital décès pour les fonctionnaires ?
5. Quels sont les interlocuteurs privilégiés selon les recommandations HAS ?

Réponses : **1.** La protection collective sur l'individuelle. · **2.** Au moins une fois par an. · **3.** La CPAM. · **4.** 12 fois le dernier traitement indiciaire brut mensuel. · **5.** Le médecin du travail et l'infirmier.

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.